BONUS 3

Klinik Soruya Göre Rapor: 30 Klinik Soru

İstemde yazan soru ne olursa olsun, raporunuzun ilk cümlesi o soruya yanıt vermelidir. En sık 30 klinik soru için: raporun mutlaka yanıtlaması gerekenler, negatif cümle ve pozitif cümle.

İçindekiler

Klinik soru neden önce gelir

Nöroradyoloji — 5 soru

Toraks — 7 soru

Abdomen ve pelvis — 10 soru

Vasküler — 3 soru

Kas-iskelet ve omurga — 5 soru

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Klinik soru neden önce gelir

HAZIRLA adımında istemi okursunuz; ÖZETLE adımında ona yanıt verirsiniz.

> *İstemi yazan hekim raporu açtığında tek bir şey arar: sorusunun yanıtı. Bulamazsa telefon eder ya da raporu yanlış yorumlar.*

1. **İstemi okuyun ve soruyu tek kelimeye indirin** — «apandisit?», «kanama?», «taş?».
2. **Taramanızı yine tam yapın** — soru odak verir, ama diğer bölgeler atlanmaz.
3. **Sorunun «mutlaka» listesini Bulgular'da karşılayın** — her madde ya pozitif ya da önemli negatif olarak yazılır.
4. **Sonuç'un ilk cümlesi soruya yanıttır** — pozitifse bulgu ve gerekiyorsa bildirim; negatifse açık negatif cümle.
5. **Sınırlılığı yazın** — tetkikin soruyu dışlamakta yetersiz kaldığı durumda bunu açıkça belirtin.

İstem belirsizse

«Kontrol», «ağrı» gibi belirsiz istemlerde klinik bilgiyi dosyadan veya istemi yazan hekimden öğrenmeye çalışın. Öğrenemediyseniz raporu en olası soruya göre yapılandırın ve sık nedenleri tek tek yanıtlayın.

BÖLÜM 1

Nöroradyoloji

5 klinik soru

01 «İnme?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastsız beyin BT ± BT anjiyografi; MR-DAG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Kanama var mı, yok mu (ilk cümle)
- Erken iskemi bulgusu ve sulama alanı
- Hiperdens arter işareti
- BT anjiyografi yapıldıysa büyük damar oklüzyonu
- Bildirim saati

NEGATİF CÜMLE
İntrakraniyal kanama saptanmadı. Erken iskemik değişiklik izlenmedi; erken iskemik inme kontrastsız BT'de görülmeyebilir.

POZİTİF CÜMLE
İntrakraniyal kanama yok; [sağ/sol] MCA sulama alanında erken akut iskemi bulguları. İnme protokolü kapsamında [saat]'te bildirilmiştir.

02 «Kafa travması — kanama?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastsız beyin BT (beyin ve kemik penceresi)

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Ekstraaksiyel ve parankimal kanama
- Kitle etkisi ve orta hat şifti (mm)
- Bazal sisternler
- Kalvaryum ve kafa tabanı kırığı
- Pnömosefali

NEGATİF CÜMLE
Akut intrakraniyal kanama, kitle etkisi veya kalvaryum kırığı saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] akut [epidural/subdural] hematom; [.. mm] orta hat şifti. [Saat]'te bildirilmiştir.

03 «Ani şiddetli baş ağrısı — SAK?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastsız beyin BT ± BT anjiyografi

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Subaraknoid kanama ve dağılımı
- Hidrosefali
- İntraventriküler veya parankimal kanama
- Anevrizma için BTA önerisi

NEGATİF CÜMLE

Subaraknoid kanama saptanmadı. BT'nin duyarlılığı başlangıçtan geçen süreyle azalır; klinik şüphe sürüyorsa ileri değerlendirme klinik karara bırakılır.

POZİTİF CÜMLE

[Bazal sisternlerde] subaraknoid kanama; hidrosefali [yok/var]. BT anjiyografi önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.

04 «Kitle?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastlı beyin MR (BT'de şüphe varsa)

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Lezyon sayısı, yeri, boyutu
- İntra/ekstraaksiyel ayrımı
- Ödem ve kitle etkisi
- Herniasyon
- En olası ayırıcı tanı

NEGATİF CÜMLE

Kontrastlı beyin MR'da kitle lezyonu veya patolojik kontrastlanma saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE

[Sağ/Sol] [lob]'da [.. mm] [intraaksiyel/ekstraaksiyel] kitle; [ayırıcı tanı]. Herniasyon bulgusu [yok/var].

05 «Hidrosefali / şant disfonksiyonu?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastsız beyin BT; önceki tetkikle karşılaştırma

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Ventrikül boyutunda önceki tetkike göre değişim
- Periventriküler ödem
- Şant kateter ucu konumu
- Kanama

NEGATİF CÜMLE

Önceki tetkike göre ventrikül boyutlarında değişiklik izlenmedi; şant kateter ucu [konum].

POZİTİF CÜMLE

Önceki tetkike göre ventriküllerde belirgin genişleme; şant disfonksiyonu lehine olabilir. [Saat]'te bildirilmiştir.

BÖLÜM 2

Toraks

7 klinik soru

06 «Pnömotoraks?»

Sık kullanılan tetkik: Akciğer grafisi; gerekirse BT veya POCUS

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Pnömotoraks var mı, taraf
- Ölçü veya miktar
- Tansiyon lehine bulgu
- Eşlik eden kosta kırığı, ciltaltı amfizem

NEGATİF CÜMLE
Pnömotoraks saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] pnömotoraks, apekste [.. mm]; tansiyon lehine bulgu [yok/var]. [Saat]'te bildirilmiştir.

07 «Pnömoni?»

Sık kullanılan tetkik: Akciğer grafisi; gerekirse toraks BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Konsolidasyon var mı, lob/segment
- Plevral efüzyon
- Kavitasyon veya apse
- Önceki tetkike göre değişim

NEGATİF CÜMLE
Akciğer parankiminde pnömoni lehine konsolidasyon saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] [lob] konsolidasyon; klinik ile birlikte pnömoni ile uyumlu olabilir. Plevral efüzyon [yok/var].

08 «Pulmoner emboli?»

Sık kullanılan tetkik: BT pulmoner anjiyografi

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Opasifikasyonun yeterliliği
- Emboli var mı ve en proksimal düzey
- Sağ ventrikül yüklenmesi
- Alternatif tanı (pnömoni, efüzyon)

NEGATİF CÜMLE
Pulmoner arter opasifikasyonu yeterli; pulmoner tromboemboli saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Bilateral] [lober/segmental] akut pulmoner tromboemboli; sağ ventrikül yüklenmesi [yok/var]. [Saat]'te bildirilmiştir.

09 «Aort diseksiyonu?»

Sık kullanılan tetkik: BT anjiyografi (kontrastsız + arteriyel faz)

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Diseksiyon var mı
- Asendan aorta tutulumu
- Dal tutulumu ve organ perfüzyonu
- Perikardiyal efüzyon, mediastinal hematom
- İntramural hematom

NEGATİF CÜMLE
Aort diseksiyonu, intramural hematom veya penetran ülser saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Stanford A/B] aort diseksiyonu; [dal tutulumu]. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.

10 «Tüp / kateter yeri?»

Sık kullanılan tetkik: Yatak başı AP akciğer grafisi

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Her cihazın ucu nerede
- ETT için karinaya uzaklık
- NG tüpün mide içinde olup olmadığı
- Girişime bağlı pnömotoraks

NEGATİF CÜMLE
ETT ucu karinanın [.. cm] üzerinde, NG tüp ucu mide projeksiyonunda, SVK ucu superior vena kava projeksiyonunda; pnömotoraks yok.

POZİTİF CÜMLE
[NG tüp ucu sağ ana bronş projeksiyonunda], uygun konumda değil. Kullanılmadan önce [saat]'te bildirilmiştir.

11 «Kalp yetmezliği / pulmoner ödem?»

Sık kullanılan tetkik: Akciğer grafisi; akciğer USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Kalp boyutu (projeksiyonu belirterek)
- Vasküler konjesyon ve interstisyel ödem
- Plevral efüzyon
- Önceki tetkike göre değişim

NEGATİF CÜMLE
Pulmoner ödem veya plevral efüzyon lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
Pulmoner ödem lehine bulgular ve bilateral az miktarda plevral efüzyon; önceki tetkike göre [artış/gerileme].

12 «Plevral efüzyon?»

Sık kullanılan tetkik: Akciğer grafisi; toraks USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Efüzyon var mı, taraf
- Miktar
- İçerik (USG: anekoik, septalı, ekojen)
- Altta yatan parankim patolojisi
- Girişim için uygun pencere (istenmişse)

NEGATİF CÜMLE
Plevral efüzyon saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] [az/orta/fazla] miktarda [anekoik/komplike görünümlü] plevral efüzyon.

BÖLÜM 3

Abdomen ve pelvis

10 klinik soru

13 «Apandisit?»

Sık kullanılan tetkik: Çocuk/genç/gebe: USG; erişkin: kontrastlı BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Apendiks görüldü mü
- Çap, duvar, çevre yağ dokusu
- Apendikolit
- Perforasyon, apse
- Görülmediyse bunun apandisiti dışlamadığı

NEGATİF CÜMLE
Apendiks doğal görünümde izlenmiştir; akut apandisit lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
Akut apandisit ile uyumlu bulgular; perforasyon veya apse [yok/var]. [Saat]'te bildirilmiştir.

14 «Taş? (renal kolik)»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastsız BT (taş protokolü); USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Taş var mı, yeri ve boyutu (mm)
- Hidronefroz derecesi
- Kontralateral böbrek
- Alternatif tanı

NEGATİF CÜMLE
Üriner sistemde taş veya hidronefroz saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] [distal] üreterde [.. mm] taş ve [hafif] hidroüreteronefroz.

15 «Kolesistit?»

Sık kullanılan tetkik: Batın USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Taş
- Duvar kalınlığı ve perikolesistik sıvı
- Sonografik Murphy
- Koledok çapı
- Komplikasyon (gangren, perforasyon)

NEGATİF CÜMLE
Safra kesesi doğal; taş veya akut kolesistit bulgusu saptanmadı. Koledok [.. mm].

POZİTİF CÜMLE
Akut taşlı kolesistit ile uyumlu bulgular; koledok [.. mm]. [Saat]'te bildirilmiştir.

16 «Obstrüksiyon / ileus?»

Sık kullanılan tetkik: Ayakta direkt batın grafisi; kontrastlı abdomen BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Obstrüksiyon var mı, ince/kalın barsak
- Geçiş zonu ve olası neden
- Strangülasyon/iskemi bulguları
- Serbest hava

NEGATİF CÜMLE
Mekanik barsak obstrüksiyonu lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Bölge] de geçiş zonu gösteren mekanik ince barsak obstrüksiyonu; iskemi bulgusu [yok/var].

17 «Perforasyon / serbest hava?»

Sık kullanılan tetkik: Ayakta akciğer grafisi; abdomen BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Serbest hava var mı
- Olası perforasyon yeri
- Serbest sıvı, apse
- Yakın zamanda cerrahi öyküsü

NEGATİF CÜMLE
Serbest hava saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
Pnömoperitoneum; [olası lokalizasyon] perforasyonu lehine. [Saat]'te bildirilmiştir.

18 «Pankreatit / komplikasyon?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastlı abdomen BT (genellikle başlangıçtan bir süre sonra)

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Pankreatit tipi (ödematöz/nekrotizan)
- Peripankreatik sıvı veya koleksiyon
- Vasküler komplikasyon
- Safra taşı

NEGATİF CÜMLE
Akut pankreatit lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
Akut [nekrotizan] pankreatit; [koleksiyon/vasküler komplikasyon] [yok/var].

19 «Travma — solid organ yaralanması?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastlı travma BT; FAST

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Her solid organ tek tek
- Hemoperitoneum ve miktarı
- Aktif ekstravazasyon
- Barsak/mezenter yaralanması
- Kemik yaralanmaları

NEGATİF CÜMLE
Solid organ yaralanması, serbest sıvı veya aktif kanama lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Organ] yaralanması ve hemoperitoneum; aktif ekstravazasyon [yok/var]. [Saat]'te bildirilmiştir.

20 «Ektopik gebelik?»

Sık kullanılan tetkik: Transvajinal ve transabdominal pelvik USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Uterin gebelik var mı
- Adneksiyel kitle
- Serbest sıvı ve içeriği
- Overlerin durumu

NEGATİF CÜMLE
Uterin kavitede [yolk kesesi içeren] gebelik kesesi izlenmiştir; adneksiyel kitle veya serbest sıvı saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
Uterin gebelik izlenmedi; [sağ/sol] adneksiyel kitle ve serbest sıvı ile ektopik gebelik lehine bulgular. [Saat]'te bildirilmiştir.

21 «Divertikülit?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastlı abdomen-pelvis BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Tutulan segment
- Komplike mi (apse, perforasyon, fistül)
- Apse boyutu
- Alternatif tanı

NEGATİF CÜMLE
Divertikülit lehine bulgu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Sigmoid] kolonda akut [komplike/komplike olmayan] divertikülit; apse [yok/var, .. mm].

22 «Karın ağrısı — nedeni?»

Sık kullanılan tetkik: Kontrastlı abdomen-pelvis BT veya USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Akut cerrahi patoloji var mı
- Sık nedenler tek tek: apendiks, safra kesesi, barsak, üriner sistem
- Serbest sıvı ve serbest hava
- Vasküler patoloji (aort)

NEGATİF CÜMLE
Karın ağrısını açıklayacak akut patoloji saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Bulgu]; karın ağrısını açıklayabilir. [Gerekirse bildirim].

BÖLÜM 4

Vasküler

3 klinik soru

23 «DVT?»

Sık kullanılan tetkik: Alt ekstremite venöz Doppler USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Hangi segmentler değerlendirildi
- Kompresibilite
- Trombüsün proksimal sınırı
- Baldır venleri değerlendirildi mi

NEGATİF CÜMLE

[Sağ/Sol] alt ekstremite derin venlerinde [değerlendirilen segmentlerde] tromboz saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE

[Sağ/Sol] [femoropopliteal] segmentte akut DVT; proksimal sınır [düzey]. [Saat]'te bildirilmiştir.

24 «Testis torsiyonu?»

Sık kullanılan tetkik: Skrotal gri skala ve renkli Doppler USG

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- İntratestiküler akım (karşı tarafla karşılaştırmalı)
- Testis boyutu ve ekoyapısı
- Spermatik kord
- Alternatif tanı (epididimit)

NEGATİF CÜMLE

Bilateral testiküler akım simetrik; torsiyon lehine bulgu saptanmadı. Akım varlığı aralıklı torsiyonu tamamen dışlamaz.

POZİTİF CÜMLE

[Sağ/Sol] testiste akım izlenmedi; torsiyon ile uyumlu. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.

25 «AAA / rüptür?»

Sık kullanılan tetkik: Abdominal aort USG; BT anjiyografi

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Maksimum çap (mm)
- Renal arterlerle ilişkisi
- Periaortik hematom (rüptür)
- Semptomatik hastada USG'nin sınırlılığı

NEGATİF CÜMLE

Abdominal aort normal çapta; anevrizma saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE

İnfrarenal AAA, maksimum çap [.. mm]; rüptür bulgusu [yok/var]. [Saat]'te bildirilmiştir.

BÖLÜM 5

Kas-iskelet ve omurga

5 klinik soru

26 «Kırık?»

Sık kullanılan tetkik: Direkt grafi (en az iki projeksiyon); gerekirse BT/MR

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Kırık var mı, kemik ve seviye
- Eklem içi uzanım
- Deplasman, açılanma
- Çıkık
- Grafi negatifse okült kırık olasılığı

NEGATİF CÜMLE
Akut kırık veya çıkık saptanmadı. Klinik şüphe sürüyorsa okült kırık grafiyle dışlanamaz.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] [kemik] [lokalizasyon] kırığı; [eklem içi/eklem dışı], [deplasman].

27 «Kalça kırığı? (yaşlı, düşme)»

Sık kullanılan tetkik: Pelvis AP + kalça lateral; negatifse MR veya BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Femur boynu ve intertrokanterik bölge
- Deplasman
- Pelvis halkası ve pubik ramuslar
- Okült kırık için ileri tetkik önerisi

NEGATİF CÜMLE
Kalça ve pelviste akut kırık saptanmadı. Klinik şüphe yüksekse okült kırık açısından MR veya BT önerilir.

POZİTİF CÜMLE
[Sağ/Sol] femur boyun kırığı ([deplase/deplase olmayan]).

28 «Kord basısı / kauda equina?»

Sık kullanılan tetkik: Tüm spinal veya lomber MR

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Bası var mı, seviye ve neden
- Kordda sinyal değişikliği
- Kauda equina kökleri
- Ek seviyeler

NEGATİF CÜMLE
Spinal kord veya kauda equina basısı saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Seviye] düzeyinde [neden] ile spinal kord basısı. Acil bulgu; [saat]'te bildirilmiştir.

29 «Servikal travma — kırık?»

Sık kullanılan tetkik: Servikal vertebra BT

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Dizilim
- Kırık ve instabilite bulguları
- Kraniyoservikal bileşke
- Prevertebral yumuşak doku
- Ligamentöz yaralanma için MR gerekliliği

NEGATİF CÜMLE
Servikal vertebralarda akut kırık veya dizilim bozukluğu saptanmadı.

POZİTİF CÜMLE
[Seviye] düzeyinde [kırık/çıkık]; instabilite açısından [saat]'te bildirilmiştir.

30 «Septik artrit / osteomiyelit?»

Sık kullanılan tetkik: Direkt grafi; USG (efüzyon); MR

RAPOR MUTLAKA YANITLAMALI

- Eklem efüzyonu
- Kemik iliği tutulumu
- Yumuşak doku apsesi
- Görüntülemenin sınırlılığı (aspirasyon gerekliliği klinik karardır)

NEGATİF CÜMLE
[Eklem]de efüzyon saptanmadı; osteomiyelit lehine kemik iliği değişikliği izlenmedi.

POZİTİF CÜMLE
[Eklem]de efüzyon ve [kemik iliği ödemi/apse]; septik artrit/osteomiyelit açısından acil klinik değerlendirme önerilir. [Saat]'te bildirilmiştir.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Hızlı bonus · Tek Sayfa Rapor Kontrol Listesi'ni açın. Klinik soruya yanıt, taraf, ölçü, karşılaştırma ve bildirim: imzadan önce bir dakikada kontrol edin.

Tam rapor kalıpları için **Ana materyal · 120 Hazır Rapor Şablonu**'na dönebilirsiniz.